

03. 객혈

- 중요 포인트

- 병력청취에서 **대량 객혈**인지 확인 (한번에 종이컵 반컵이상 or 하루동안 두세컵)
- 응급 관련 할것들 (V/S 확인, 탈수증상, 응급상황 교육) 까먹지 않기
- 교육에서 위험요인 줄이기 꼭하기

- 평가 목표

원인				
기도관련 질환			기관지염, 기관지 확장증 등	
폐실질 질환			결핵, 폐렴 등	
심혈관계 이상			폐색전증 등	
기타			혈액응고병증, 약물 등	
평가목표				
1) 병력청취와 신체진찰로 원인 장기의 감별과 적절한 진단 및 치료 계획 수립할 수 있는지				
2) 특히 응급치료가 필요한 환자를 감별할 수 있는지				
구체적인 성과				
병력 청취	객혈과 다른 출혈의 가능성 구별		토혈과의 감별: 소화기 증상 및 음식물 섞여있는지 단순 구강출혈: 출혈 당시 상황(양치, 외상, 물어나오는지)	
	객혈의 정도 추정 및 응급처치가 필요한 대량 객혈 감별		객혈 양 확인, 전신증상-어지럼증/호흡곤란/소변량변화/두근거림	
	원인 질환 감별		객혈 양상/동반증상/과거력/약물력/가족력	
	출혈 성향을 포함한 객혈의 위험요인 평가		동반증상-출혈 경향성 확인 위험요인: 과거력/가족력/사회력-환경?	
신체 진찰	원인질환 감별		구강, 비강내 확인 폐진찰 (시축타청)	
	대량 출혈에 따른 신체증상과 징후 파악		V/S 확인 눈(빈혈), 입(탈수), 피부 긴장도 소견 확인	
진단 및 치료	원인 질환 감별	기관지확장증	CXR, Chest CT	항생제, 기관지동맥색전술
		폐결핵	CXR, 객담배양, 객담항산균도말, TB-PCR	항결핵제
		폐흡충증	CXR, Chest CT, 객담배양, ELISA	Praziquantel
		폐암	CXR, Chest CT, 기관지내시경, 조직검사	수술, 항암제, 방사선
		혈액응고장애	혈액검사(CBC, 혈액응고인자), 혈액응고검사	약물중단, 원인 질환 치료
	응급치료가 필요한 환자 감별		-v/s 흔들리는 대량객혈 환자 – 기관지동맥색전술 -폐색전증 D-dimer, Chest CT(조영제) -> 항응고제, 혈전용해제, 혈전제거술	
	환자 교육	객혈의 심각성과 응급조치에 대해 교육		대량(종이컵 한 컵 이상)으로 피를 토할 시 응급상황이니 즉시 내원하도록 교육 출혈 심하여 빈혈 소견(숨이 차거나 어지럽거나) 보이는 경우 수액 공급이나 수혈 필요함 설명
위험 요인을 줄이는 교육		위험요인 줄이기: 호흡기 자극될만한 찬공기, 매연 피하기/침구류 관리:일주일에 한번 이상 뜨거운 물로 세탁/가습기 사용: 호흡기를 축축하게/환절기에 마스크 착용/손위생		

● 원인 질환 정리

질환		질환 설명	병력청취	신체진찰	검사	치료	
상기도	상기도/단순 구강출혈	목이나 입안의 미세혈관이 터져서 일시적으로 피가 섞여 나오는 상태	양치 중 출혈 출혈 소량	구강 시진: 출혈 (+)	-	경과 관찰	
하 기 도	염 증 / 감 염	만성 기관지염	기관지에 오랫동안 염증이 생겨 점막이 약해지면서, 기침할 때 가래와 함께 피가 배어 나오는 상태	기침, 가래 출혈 소량	-	CXR 혈액검사 (CBC) 객담배양검사	항생제 진해제 기도확장제(필요시)
		기관지 확장증 2+2	기관지가 탄력을 잃고 주머니처럼 늘어나 버려, 그 안에 고인 가래와 세균이 조직과 혈관을 자극해 반복적으로 피가 섞여 나옴	기침, 가래 잦은 상기도 감염 Hx	폐 청진: 수포음	CXR Chest CT	항생제 기관지동맥색전술 (대량 객혈시) 폐절제술
		폐렴	폐 조직에 세균이나 바이러스가 침투해 염증이 생기면서, 피가 가래에 섞여 나옴	발열,기침,가래(화농성)	폐 청진: 수포음 타진음, 성음진탕 증가	CXR Chest CT 혈액/객담 배양	경험적 항생제
		폐결핵 5+4	결핵균이 폐 조직을 파괴하며 파고들면서 혈관을 손상시켰기 때문에, 만성적인 기침과 함께 선홍색 피가 섞여 나옴	기침, 가래 발열, 체중감소, 피로 야간발한 결핵 Hx	-	CXR 객담항산균도말 객담배양 TB-PCR	항결핵제
		폐흡충증 0+1	익히지 않은 민물 게 등을 통해 들어온 기생충이 폐에 자리를 잡고 염증을 일으켜, 가슴 통증과 함께 피 섞인 가래를 유발	가래 민물게장 먹은 Hx.	-	CXR Chest CT 객담 검사 ELISA	구충제(Praziquantel)
	COPD 급성악화 1+0						
	혈관	폐색전증	다리 등에서 생긴 피떡(혈전)이 폐 혈관을 갑자기 막아버려, 폐 조직 일부가 손상	갑작스러운 호흡곤란 흉통 수술/외상력 Hx	폐청진: 수포음 목정맥 확장 사지 부종	Chest CT 심초음파 혈액검사 (D-dimer)	항응고제 V/S 불안정시 -> 혈전용해제 or 혈전제거술
종양	폐암	폐에 생긴 나쁜 혹(종양)이 주변 혈관을 파고들어 손상을 주기 때문에, 지속적으로 피 섞인 가래가 나오거나 기침이 심해질 수 있음	기침 체중감소 Heavy smoker	-	기관지내시경 경피적 미세침흡인술(조직검사)	폐절제술 항암치료 방사선 치료	
소화기	식도정맥류 출혈	폐가 아니라 식도의 혈관이 터진 것	객혈이 아닌 토혈	-	위내시경	내시경적 지혈 베타차단제	
혈액	혈액응고장애	몸속에서 피를 멎게 하는 성분이 부족해져서, 폐나 기관지의 작은 자극에도 쉽게 피가 나고 잘 멈추지 않는 상태	출혈 경향:쉽게 멎 둘 와파린, NOAC 등 약물 hx	-	혈액검사(CBC, 혈액 응고인자)	약물 중단 원인 질환 치료	

O	언제 당시 어떤 상황 - 구토, 기침, 양치							
L	-							
D	지속 시간 몇 번							
Co	점점 심해지는지							
Ex	이전 경험 - 치료							
C	개방형: “어떻게 아픈지 자세히 설명해주시겠어요?” 다른 출혈과 감별) [토혈]: 구역 / 음식물 [구강내 상처, 코피]: 입안 상처 / 코피 양상) 양(종이컵 반컵/소주잔 2) / 색 / 거품 / 피떡 정도) 일상생활에 지장 (-> 공감 PPI)							
A	개방형: “다른 불편한 곳은 없으세요? 네. 그럼 제가 몇가지 자세하게 확인해보겠습니다.” 전신) 발열/오한/체중변화/피로/식욕부진 r/o 암, 결핵 응급/탈수) 목마름/어지럼/두근거림/숨 참/소변량 감소 출혈) 멍이 잘 듦/피가 잘 안 멎음/잇몸피(양치) 호흡기-상기도) 기침/가래(양상-언제부터/색/양/성상(끈적, 묽은지))/콧물/인후통 호흡기-하기도) 호흡곤란/쌉쌉거림/야간발한 - *호흡곤란은 모든 질환에서 있을 수 있을 것 같다 (폐색전증 의심되면 갑작스러웠는지?) 소화기) 복통/혈변/황달							
F	개방형: “증상이 어떨 때 좀 괜찮아지고/심해지나요?” 식사-민물게장,가재류,회 섭취							
E	건강검진 - 흉부 x 선 예방접종(폐렴구균/독감)							
외	외상 수술 - 장기간 입원 등 못 움직이는 상황 있었는지							
과	기저질환 호흡기 질환 Hx 1) 어릴 때나 평소에 감기나 폐렴을 자주 앓으시는 편? 2) 결핵 3) 천식/알레르기							
약	복용 중인 약물 피 묻게 하는 약 (아스피린, 와파린, 헤파린)							
사	기본 : 음주/흡연/커피/직업/스트레스/운동 직업 - 근무환경							
가	기저질환 폐질환 - 결핵, 폐암 : 가족 중에 폐쪽이 안좋은 분이 계실까요? 혈액응고질환							
여	-							
PEx	동의 구하기, 손 씻기 v/s 확인-눈-코-입-목-사지-폐							
	기본	V/S 확인 (혈압, 맥박, 호흡수, 체온) > 나중에 수액/수혈 필요할 수 있습니다. 1 눈: 빈혈, 황달 2 코: 코피, 비강 점막 확인 - 비경 사용 3 입: 탈수 + 구강 내(잇몸), 인두 시진 4 목: 경부 림프절 + 갑상샘 5 사지 : 피부 긴장도, 다리부종						
	호흡기	<table><tr><td>호흡</td><td>시진</td><td>옷 올려보기 눈으로 보고 숨깊게 쉬어보셈 + 기침도 해보셈 (앞뒤 다 확인)</td></tr><tr><td></td><td>촉진</td><td>등 뒤만 1 양 손등 대고 아 해보세요 4 번 2 엄지 모아지게 흉곽 감싸 안고 조이기</td></tr></table>	호흡	시진	옷 올려보기 눈으로 보고 숨깊게 쉬어보셈 + 기침도 해보셈 (앞뒤 다 확인)		촉진	등 뒤만 1 양 손등 대고 아 해보세요 4 번 2 엄지 모아지게 흉곽 감싸 안고 조이기
호흡	시진	옷 올려보기 눈으로 보고 숨깊게 쉬어보셈 + 기침도 해보셈 (앞뒤 다 확인)						
	촉진	등 뒤만 1 양 손등 대고 아 해보세요 4 번 2 엄지 모아지게 흉곽 감싸 안고 조이기						

				☐ 숨 쉬어 보세요 : 흉곽 벌어짐/대칭	
			타진	(뒷면) ㄹ자로 등 6 번+아래옆구리 2 번	
			청진	청진기 차가워요+데우기 (뒷면) ㄹ자로 등 6 번+아래옆구리 2 번 (앞면) 6 군데	
	협조해주셔서 감사합니다. 불편한 건 없으셨나요? 손씻기				
진단 치료 교육	기본	Chest X ray, Chest CT 혈액검사(빈혈수치, 혈액응고인자) 혈액응고검사 가래 배양 검사 폐기능검사	안정 + 기침,가래 증상 조절 약(진해거담제)		
	만성 기관지염	-	생활습관개선		
	기관지확장증	-	항생제 대량 객혈시 기관지동맥색전술		
	폐렴	-	항생제 항바이러스제		
	폐결핵	객담검사 (객담 항산균 도말) TB-PCR	항결핵제		
	폐암	기관지내시경, 조직검사	수술, 항암치료, 방사선		
	폐색전증	D-dimer, 조영제 CT, 심초음파	항응고제, 혈전용해제, 혈전제거술		
	폐흡충증	ELISA	구충제		
	(안심/진단검사/치료응급/회피교정/검진접종) [안심] 피와 관련되었기 때문에 환자 공포감 안심시켜 주기! [진단검사치료] CXR CT 혈액검사 + 추가 검사(원인 질환에 따라) 안정 + 증상 조절 약물 + 치료(원인 질환에 따라) [응급] 대량(종이컵 반 컵 이상)으로 피를 토할 시 응급상황이니 즉시 내원하도록 교육 출혈 심하여 빈혈 소견(숨이 차거나 어지럽거나) 보이는 경우 수액 공급이나 수혈 필요함 설명 [회피/교정] 생활습관 교정 금연 위험요인 줄이기: -2 가지 이상 말하기? 손마가침 -호흡기 자극될만한 찬공기, 매연 피하기 -침구류 관리:일주일에 한번 이상 뜨거운 물로 세탁 -가습기 사용: 호흡기를 촉촉하게 -환절기에 마스크 착용 -손위생 [검진/접종] 독감 접종 매년 폐렴구균 예방접종 대상: 65 세 이상 만성 폐질환자에서 권고 폐암 검진: 55 세 이상, 30 갑년 흡연력 이상이 2 년에 한번 폐암검진 권고				
	PPI	궁금하신 점 있으실까요?			